



EVCP 2011

Connaissances pratiques

Médecine générale

Cette annale contient

8 sujets · 8 questions

01 SUJET 1

VIGNETTE CLINIQUE

: Endocrinologie Une patiente de 42 ans consulte pour la découverte d'une petite masse cervicale antérieure. A la palpation vous confirmez qu'il s'agit d'un nodule thyroïdien unique d'environ 2 cm.

1

QUESTION

Quels sont les éléments d'interrogatoire et d'examen clinique qui vous paraissent essentiels (en dehors des signes d'une éventuelle dysthyroïdie) ?

2

QUESTION

Citez les deux examens complémentaires à réaliser.

02 SUJET 2

VIGNETTE CLINIQUE

: Infectiologie Une femme de 54 ans, ménopausée, sous hormonothérapie substitutive, sans antécédent particulier se présente à votre cabinet avec les signes suivants : Fièvre à 40 °C Douleur brutale de l'hémithorax gauche Fréquence respiratoire : 15/mn TA 130/60 Pouls 110/mn 1 - Quel diagnostic le plus probable évoquez-vous ? Sur quels éléments sémiologiques cliniques vous basez-vous pour le confirmer ? 2 - Quel serait votre traitement de première intention ? Rédigez votre ordonnance.

03 SUJET 3

VIGNETTE CLINIQUE

: Métabolisme Un homme de 60 ans vous consulte pour une fatigue récente sans point d'appel particulier. Dans le bilan biologique que vous demandez, vous découvrez une hypercalcémie (3 mmol par litre ou 120 mg par litre). Il ne prend aucun traitement.

1

QUESTION

Quels sont les 3 principaux diagnostics que vous évoquez ? Quels sont les 3 examens biologiques utiles au diagnostic étiologique que vous devez effectuer avant le recours au spécialiste ?

04 SUJET 4**VIGNETTE CLINIQUE**

: Pneumologie Monsieur X âgé de 78 ans, fumeur depuis l'âge de 20 ans (un paquet par jour), aux antécédents de cardiopathie ischémique est porteur d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Il consulte pour la cinquième fois dans l'année pour une exacerbation de sa BPCO avec fièvre à 38,5°C.

1 QUESTION

Sur quels critères cliniques principaux portez-vous le diagnostic d'exacerbation d'origine infectieuse ?

2 QUESTION

Quels catégories de traitements médicamenteux prescrivez-vous (en dehors de l'oxygène) ?

05 SUJET 5**VIGNETTE CLINIQUE**

: Gastro-entérologie Homme de 72 ans qui se présente pour épigastralgies. Ses antécédents : HTA, cardiopathie ischémique, diabète non insulino-dépendant, gonarthrose. Son traitement, Aspirine, Amlodipine, Metformine, Aténolol et Kétoprofène si douleurs. La douleur est présente depuis 48 heures, intense à type de crampes, plus ou moins calmée par l'alimentation. Elle le réveille la nuit. Il n'y a pas d'irradiation, ni nausées ni vomissements et le ventre est souple.

1 QUESTION

Quel est le risque immédiat chez ce patient Citez 5 diagnostics différentiels à éliminer pouvant entraîner un risque vital.

06 SUJET 6**VIGNETTE CLINIQUE**

: Gériatrie En période hivernale, vous êtes appelé chez une dame de 84 ans. Elle a été retrouvée par terre par sa voisine. Elle présente une confusion récente et inhabituelle selon son entourage.

1

QUESTION

Citez 3 éléments importants de l'examen clinique.**2**

QUESTION

Citez 5 hypothèses diagnostiques**07****SUJET 7****VIGNETTE CLINIQUE**

: Cardiologie Madame M., 81 ans, traitée pour hypertension artérielle est suivie par vos soins depuis 5 ans. Elle vit en maison de retraite. Sous traitement la situation est satisfaisante. Lors d'une consultation, alors que madame M. reste asymptomatique avec un examen clinique normal, vous retrouvez un rythme cardiaque irrégulier, à 74 pulsations par minute en moyenne, avec un électrocardiogramme qui confirme une fibrillation auriculaire permanente sans autre anomalie. 1 - Quel bilan biologique complémentaire réalisez vous ? 2 - Devant la normalité de celui ci, quel traitement au long cours mettez vous en uvre et avec quel objectif ? Argumentez votre réponse.

08**SUJET 8****VIGNETTE CLINIQUE**

: Rhumatologie Vous recevez une patiente de 74 ans pour une lombalgie aiguë, invalidante sans notion de traumatisme. Elle n'a pas d'antécédents médicaux ni chirurgicaux. L'examen clinique: raideur rachidienne, examen neurologique normal. Les radiographies du rachis lombaire et du bassin retrouvent une fracture-tassement de L1. 1 - Quel est le diagnostic étiologique le plus probable ? Citez deux autres diagnostics étiologiques à évoquer. 2 - Citez 4 explorations biologiques complémentaires à envisager en première intention

FILENAME \p G:\Pae\2011\Spec.71\EVCP.71.DOC Page
NUMPAGES rg\gTIA h;CÃ h3QS h6uñ h- 9 gd;CÃ gdÙu gda gd6uñ hóuK gdÃ! hÇ,' hñ/Ê
sk`UM~ hÝ9s hs?G hÇ!- h@az ð P gdÝ9s gdTe8 þgdÙu UÔhdP xnÖäCÿ òùOh
ODONTOLOGIE jeò+ Prodiser Titre Document Microsoft Word MSWordDoc
Word.Document.8